



## Rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une complication du diabète qui affecte la rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de l'œil. Elle survient lorsque l'hyperglycémie endommage les petits vaisseaux sanguins de la rétine, ce qui peut entraîner une perte de vision.

### Qui est à risque ?

Toute personne atteinte de diabète de type 1 ou de type 2 est à risque — en particulier celles qui présentent :

- Un diabète ancien ou mal contrôlé
- De l'hypertension artérielle
- Un taux de cholestérol élevé
- Une grossesse
- Le tabagisme

Le risque augmente avec la durée du diabète.

### Stades de la rétinopathie diabétique

1. Non-proliférative légère/modérée  
Stades précoces avec de petites fuites ou gonflements.
2. Non-proliférative sévère  
Des vaisseaux bloqués entraînent un manque d'oxygène dans certaines zones de la rétine.
3. Rétinopathie diabétique proliférative  
De nouveaux vaisseaux anormaux se forment — ils sont fragiles et peuvent saigner.
4. Œdème maculaire diabétique (OMD)  
Accumulation de liquide dans la macula (centre de la rétine), provoquant une vision floue.

### Symptômes

Vous pouvez ne présenter aucun symptôme au début. Avec le temps, vous pourriez remarquer :

- Vision floue ou fluctuante
- Taches ou corps flottants



- Zones sombres ou perte de vision
- Difficulté à voir la nuit

La perte de vision peut survenir sans douleur, d'où l'importance d'examen réguliers.

## Diagnostic

La rétinopathie diabétique est diagnostiquée par :

- Un examen rétinien avec dilatation par un ophtalmologiste
- Une OCT (tomographie par cohérence optique) pour détecter l'enflure
- Une angiographie à la fluorescéine pour visualiser les vaisseaux sanguins en détail

## Options de traitement

Les stades précoces peuvent ne pas nécessiter de traitement — un contrôle strict du diabète et un suivi régulier suffisent souvent.

Pour les cas avancés :

- Injections anti-VEGF : réduisent l'enflure et empêchent la formation de nouveaux vaisseaux
- Laser focal ou en grille : colmate les fuites des vaisseaux
- Laser panrétinien (PRP) : réduit les vaisseaux anormaux
- Vitrectomie : chirurgie pour retirer le sang ou le tissu cicatriciel

## Vivre avec la rétinopathie diabétique

- Maintenez une glycémie, une tension artérielle et un cholestérol bien contrôlés
- Ne sautez pas vos examens oculaires annuels avec dilatation — même en l'absence de symptômes
- Consultez rapidement si votre vision change
- Discutez avec votre médecin des facteurs de risque à surveiller

## Foire aux questions (FAQ)

Q : La rétinopathie diabétique peut-elle être inversée ?

R : Les lésions précoces peuvent s'améliorer avec un meilleur contrôle du diabète. Les stades plus avancés peuvent être ralentis ou stabilisés, mais pas totalement inversés.



Q : Vais-je devenir aveugle ?

R : Sans traitement, la perte de vision peut être sévère. Mais avec un dépistage précoce et un traitement approprié, beaucoup de patients conservent une bonne vision.

Q : Peut-on prévenir cette maladie ?

R : Oui, en maintenant une bonne maîtrise du diabète, en évitant de fumer et en réalisant un examen oculaire annuel.